

Programme de réathlétisation d'un syndrome fémoro-patellaire

Le programme que nous vous proposons doit être proposé à votre patient en accord avec les autres professionnels prenant en charge cette pathologie et **ne devra en aucun cas se subordonner aux autres traitements mis en place.**

Phase	Durée	Objectifs	Exercices détaillés	Fréquence
1. Phase aiguë – Réduction douleur et inflammation	Semaine 1–2	◆ Diminuer douleur et contraintes fémoro-patellaires ◆ Travailler l'alignement ◆ Activer quadriceps sans douleur	◆ Repos relatif : éviter accroupissements, montées/descentes ◆ Cryothérapie : 15–20 min, 2–3x/jour ◆ Contractions isométriques du quadriceps : jambe tendue, contraction 5 sec x 10 répétitions ◆ Étirement du quadriceps et TFL : 3x30 sec ◆ Mobilisation rotulienne douce : mobilisations manuelles en glissement latéral et supérieur	Quotidien Étirements : 2x/jour
2. Réactivation musculaire ciblée	Semaine 3–4	◆ Réveiller quadriceps et fessiers ◆ Corriger valgus dynamique ◆ Améliorer contrôle moteur	◆ Clamshells avec élastique : allongé côté, genoux fléchis, ouvrir jambe – 3x12 ◆ Pont fessier : 3x15 ◆ Leg raise droit (quad control) : genou tendu, contraction quadri → 3x15 ◆ Mini squat (90° max), vérification du bon alignement genou/cheville ◆ Gainage latéral (version modifiée) : 3x30 sec	4–5x/sem Renforcement : 3x/sem min.
3. Renforcement fonctionnel progressif	Semaine 5–6	◆ Réintégrer les gestes dynamiques ◆ Améliorer tolérance au port de charge ◆ Stabiliser contrôle genou	◆ Fentes avant + latérales (contrôle genou) : 3x10 ◆ Step-down progressif (hauteur croissante) : 3x10 par jambe ◆ Wall squat (isométrique) : maintenir 30–45 sec, 3 fois ◆ Planche + reach bras/jambes : 3x30 sec ◆ Montée sur banc unilatérale lente : 3x10	3–4x/sem Étirements + gainage : régulier
4. Reprise progressive de l'activité sportive	Semaine 7+	◆ Tolérer course, changements de direction, sauts ◆ Renforcement préventif ◆ Éviter les récives	◆ Course progressive : programme run/walk ou 30-30 ◆ Sauts verticaux et latéraux (plyométrie légère) ◆ Drills techniques si sportif terrain : appuis, direction, sprint ◆ Renforcement global (squats, fentes, proprioception) ◆ Mobilité hanche/cheville + travail fessier	Course : 2–3x/sem Renforcement : 2–3x/sem Prévention : 1x/sem min.

Conseils spécifiques à la réathlétisation d'un syndrome fémoro-patellaire :

- Le **renforcement du vaste médial** est prioritaire, mais souvent secondaire à un **travail global hanche + tronc**.
- Corriger les défauts d'alignement dynamiques : **valgus du genou, déficit de contrôle de hanche/pied**.
- Éviter les douleurs > 3/10 pendant les exercices.